

09 - 09- Troubles Psychiatriques chez les patients Épileptiques - Pr. ADALI

(0:01 - 0:20)

Chers étudiants, j'ai le plaisir de traiter avec vous aujourd'hui ce cours sur les troubles psychiatriques chez les patients épileptiques. Il existe une relation étroite entre épilepsie et psychiatrie. L'incidence des troubles psychiatriques dans l'épilepsie est élevée par rapport à la population générale.

(0:21 - 0:46)

Cela constitue un problème médico-social parce que ces troubles-là ont des répercussions importantes sur la vie relationnelle. La fréquence des troubles psychiatriques est plus élevée dans l'épilepsie temporale, pharmaco-résistante et généralisée. Les actes suicidaires sont fréquents. Il existe trois rubriques de troubles psychiatriques dans l'épilepsie.

(0:47 - 1:10)

Les troubles psychiatriques de la crise épileptique, qu'on appelle les troubles critiques, qui font partie de la crise ou de ses suites immédiates. Deuxièmement, les troubles psychiatriques intercritiques et les troubles psychiatriques secondaires à une atteinte cérébrale responsable de l'épilepsie. D'abord, les manifestations psychiatriques critiques.

(1:12 - 2:05)

On note les symptômes prodromiques qui peuvent être un type d'instabilité ou de dysphorie. Les troubles psychiatriques liés à la crise, c'est soit des automatismes psychomoteurs qui peuvent être parfois mal interprétés par les non-médecins. Comme les actes d'exhibitionnisme.

Ce sont des actes qui peuvent être dangereux. La conduite automobile, la fugue, le risque de passage à l'acte, auto-hétéro-agressif est important. Les troubles psychiatriques liés à la crise peuvent être un type de perturbation de la conscience, d'état crépusculaire, c'est une altération transitoire de la vigilance avec des réalisations et maintien d'une activité souvent automatique.

(2:07 - 2:43)

Une syndrome hallucinatoire psycho-sensorielle qui est caractéristique de l'épilepsie temporale avec des hallucinations auditives, visuelles, olfactives, gustatives. Maintenant, on va passer aux manifestations psychiatriques post-critiques, c'est à dire immédiatement après la crise. Les états confusionnels, les états crépusculaires, l'automatisme psychomoteur et les troubles du comportement qui sont un motif fréquent de consultations en psychiatrie comme la fureur agressive, les fugues et les voyages pathologiques.

(2:46 - 3:14)

Les caractéristiques des troubles motocritiques sont les suivants, ils ont un début et une fin brusques, une durée brève, ils sont souvent associés à des troubles de la vigilance avec une amnésie post-critique et une récurrence sous le même mode. Maintenant, on va passer aux troubles psychiatriques intercritiques. Les troubles de l'humeur sont les plus fréquemment retrouvés dans 30 à 60 % des cas.

(3:19 - 3:40)

D'abord, on note les troubles intellectuels chez 10 % des épileptiques où le déficit intellectuel est profond. Cependant, les deux tiers des épileptiques ont un niveau intellectuel normal. Cliniquement, ça se manifeste par des troubles de la mémoire, une expression verbale laborieuse, une dradée psychique et autres.

(3:42 - 4:00)

Les troubles du comportement, un type d'agitation, colère, gestes impulsifs, crises convulsives et autres. Troisièmement, les troubles anxio-dépressifs. La dépression est le trouble psychiatrique le plus fréquemment retrouvé chez les patients épileptiques.

(4:01 - 4:31)

La mortalité par suicide est cinq fois plus importante chez les patients épileptiques par rapport à la population générale. La dépression chez les patients épileptiques a une évolution chronique avec fluctuation de l'intensité. Elle peut être de deux types dysphoriques où l'anxiété et l'irritabilité sont au premier plan, la dysthymie ou sous forme d'état dépressif majeur et mélancolie.

(4:33 - 5:14)

La dépression peut être réactionnelle ou iatrogène suite à la prise de certains antiépileptiques, notamment le phéobarbital. L'anxiété est paroxystique, réalisant des symptômes d'une attaque de panique ou durable avec des inquiétudes, des craintes, des crises, des préoccupations somatiques, des idées obsessionnelles et autres. Les troubles psychotiques peuvent être aigus. Réalisant le tableau de ce qu'on appelle la psychosictale qui est un trouble typique de l'épilepsie qui survient après un état de mal épileptique.

(5:16 - 5:36)

Surtout l'épilepsie de type temporo-frontale. Il dure de quelques jours à quelques semaines. Deuxièmement la manie postictale, c'est un épisode qui est plus durable, qui réalise un état d'excitation maniaque suite à une crise épileptique.

(5:37 - 6:10)

Les manifestations chroniques peuvent être un type de délire, un mécanisme hallucinatoire. On peut réaliser aussi un tableau de psychose hallucinatoire chronique ou un tableau simulant une symptomatologie schizophrénique. Les troubles de la personnalité, les patients épileptiques sont des patients pour la plupart dépendants, immatures et ayant une dignité sociale.

(6:11 - 6:46)

Parfois avec des traits antisociaux, réalisant des tableaux de colère explosive et comportement agressif. Ils peuvent réaliser aussi un tableau de ce qu'on appelle la personnalité épileptique. Les troubles psychiatriques chez l'enfant épileptique réalisent dans des troubles du comportement, des perturbations des affects, un syndrome hyperkinétique, des manifestations anxio-dépressives et un déficit intellectuel.

(6:49 - 7:41)

L'épilepsie est une cause d'handicap majeur, handicap maladie, handicap lié à la société et un handicap médical lié à la maladie elle-même, c'est-à-dire des patients qui doivent prendre le traitement durant toute leur vie, avec des horaires fixes, des déplacements qui sont de plus en plus difficiles pour eux. Les patients épileptiques acceptent difficilement la maladie, c'est contrainte, ils sont mal compris par les autres. Cela réalise des difficultés sociales et professionnelles.

(7:42 - 8:19)

Une limitation des possibilités, une restriction des activités et des difficultés familiales, c'est des patients qui sont généralement surprotégés par leur famille ou bien rejetés, non compris par les membres de leur famille. Tout cet impact retentit sur la qualité de vie et entraîne la précipitation des troubles du comportement. La prise en charge des troubles psychiatriques dans le cadre de l'épilepsie est médico-psycho-sociale.

(8:21 - 8:51)

Une prise en charge spécifique est nécessaire pour améliorer la qualité de vie des patients épileptiques, avec une lutte contre l'handicap causé par la maladie. Le traitement des symptômes psychiatriques est un traitement purement symptomatique, on traite la dépression par les antidépresseurs. Cependant, il faut éviter les antidépresseurs tricycliques car ils abaissent plus le seuil épileptogène.

(8:53 - 9:20)

Dans la psychose ictale et post-ictale, on prescrit les neuroleptiques. Il faut savoir que tous les neuroleptiques diminuent le seuil épileptogène, d'où la nécessité d'ajuster le traitement antiépileptique. Dans le cadre des troubles anxieux, il faut donner des anxiolytiques de

préférence qui ont une action anticonvulsivante et mieux relaxante, comme le Valium.

(9:26 - 9:56)

Il faut donner des antiépileptiques de nouvelle génération qui ont peu d'effets secondaires et une meilleure tolérance avec une préservation des fonctions cognitives. Je vous demande de vous référer à votre cours de neurologie de quatrième année. En conclusion, les troubles psychiatriques dans l'épilepsie sont cliniquement sous-diagnostiqués.

(9:57 - 10:13)

Cependant, ils ont des répercussions importantes sur la qualité de vie des patients et leur entourage. Afin d'adapter les différents traitements, une bonne collaboration entre les psychiatres et les neurologues et le médecin généraliste est indispensable. Je vous remercie.